EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL DE SAN CARLOS	N° EGRESO	:	73772
SERVICIO	:	MEL HOMBRES HSC			
FECHA	:	2023-11-08 11:15:00			

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA EULALIA CAMPOS HERRERA			RUN	: 8.421.999-1
F.Nac	: 06-11-1949	Edad	: 74 AÑOS	Género	: Femenino
Dirección	:			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: SIN INFORMACION	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2023-11-02	Fecha Egreso	: 2023-11-08 11:15:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J12-NEUMONIA VIRAL, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente femenina con antecedentes mórbidos de dm, cancer de mama en tratamiento con quimioterapia. Sin alergia conocidas. Inicia enfermedad actual hace 10 dias aprox. Cuando presenta e mialgias, tos productiva, astenia, aumento de la temperatura corporal cuantificada en 38.9 grados por lo que decide consultar. Al ingeso paciente en condiciones clínicas de cuidado, con acentuada palidez cutáneo mucosa, hidratada, afebril, desaturando hasta 86 %, rcr s/s, mv disminuido en ambos campos pulmonares con crepitos finos de predominio bibasal, abdomen depresible no doloroso, extremidades simetricas pulsos perifericos presentes. Neurologico, paciente orientada en tiempo, espacio y persona glasgow 15 pts. Examenes destaca: proteina c reactiva : 289,0 dimero d : 2.042,5
Angiotac de torax impresión:
Examen negativo para tromboembolismo pulmonar.
Condensaciones pulmonares múltiplesbilateral y opacidades centrilobulillares de probable etiología Infecciosa.
Se toma panel viral que es positivo para Human Metapneumovirus, se sospecha sobreinfección debido a leucitosis, se administra 8 días de ceftriaxona con evolución favorable, sin requerimiento de oxígeno desde hace 48hrs, por lo que se decide continuar manejo en hospitalización domiciliario hasta completar 14 días de antibiótico además de kinesioterapia respiratoria.

PLAN DE MANEJO:

Control en su cesfam al concluir antibioticoterapia.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Kinesioterapia respiratoria
3. Ceftriaxona 2gr dia a completar 14 días (8/14) EV
4. Prednisona 20mg 1 c 12hrs por 3 días
5. Bromuro de ipratropio 2 puff c 6hrs
6. Omeprazol 20mg 1 c día
7. Medicación crónica de forma habitual
8. Kinesioterapia respiratoria

EXÁMENES Y RESULTADOS

Crea 0,50, ldh 169, pcr 20,9, ma 138, k 3,70, leu 19,00, hb 9,7, inr 1,17.

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO